

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

УДК 618.19-006.6

Д.Р.Кайдарова, М.Е. Кайбаров
Казахский НИИ онкологии и радиологии

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Аннотация. В мире отмечается неуклонный рост заболеваемости населения РЩЖ. Основная доля злокачественных новообразований щитовидной железы представлена эпителиальными опухолями, которые подразделяются на высокодифференцированные, низкодифференцированные опухоли и медуллярную карциному. В связи с этим актуальным является необходимость изучения эпидемиологических аспектов РЩЖ в Республике Казахстан.

В Республике Казахстан отмечен рост заболеваемости РЩЖ за последние 5 лет (2011-2015 гг.), что, видимо, можно объяснить экологической обстановкой, дефицитом йода, ростом урбанизации.

Ключевые слова: рак щитовидной железы, эпидемиология, Республика Казахстан.

Рак щитовидной железы (РЩЖ) – одно из наиболее часто встречающихся злокачественных заболеваний органов эндокринной системы. В структуре онкологической заболеваемости на долю РЩЖ в среднем приходится около 1–3%. В мире отмечается неуклонный рост заболеваемости населения РЩЖ, однако уровень показателей в различных регионах земного шара может существенно отличаться.

Основная доля злокачественных новообразований щитовидной железы представлена эпителиальными опухолями. Они подразделяются на высокодифференцированные (папиллярный и фолликулярный рак), низкодифференцированные (анapластический рак: веретеноклеточный, мелкоклеточный и гигантоклеточный) опухоли и медуллярную карциному. Папиллярный рак является ведущим

морфологическим вариантом РЩЖ, составляя, по данным разных авторов, от 55% до 75% от всех случаев заболевания. Остальные виды злокачественных новообразований щитовидной железы встречаются реже: фолликулярная карцинома в 15–20% случаев, анапластический рак, наиболее агрессивный тип, – в 1–4%, и медуллярная карцинома – в среднем в 3–7% наблюдений [1,2,3,4].

Основной прирост заболеваемости РЩЖ в большей степени происходит за счет папиллярного типа опухоли, канцерогенез которого зависит от воздействия факторов внешней среды, что и объясняет большую вариабельность показателей заболеваемости в различных регионах мира.

По данным GLOBOCAN (2012 г.), Казахстан, несмотря на то, что он относится к региону со значительным дефицитом йода, рассматривается как один из факторов высокого риска РЩЖ, имеет низкие показатели заболеваемости данной патологии, т.е. менее 0,91 случая на 100 000 населения (стандартизованный показатель). Для сравнения, к странам с высокими показателями заболеваемости, т.е. более 4,6 случая на 100 000 населения, относятся США, Канада, Россия, Австралия. Наиболее высокими считаются сведения в отношении жителей Меланезии/Новой Каледонии – 71,4 на 100 000 населения у женщин и 10,4 на 100 000 у мужчин [5].

В РК, как и в других странах, наблюдается рост заболеваемости РЩЖ. Так анализ показателей заболеваемости за 2011 – 2015 г.г. выявил рост заболеваемости с 2,5‰ в 2011 г. до 3,5‰ в 2015 г. (интенсивные показатели), что соответствует 411 новым случаям РЩЖ в 2011 г. и 619 – в 2015 г. в абсолютных цифрах (рисунок 1). Прирост заболеваемости за 5 лет составил 15,5% [6,7]

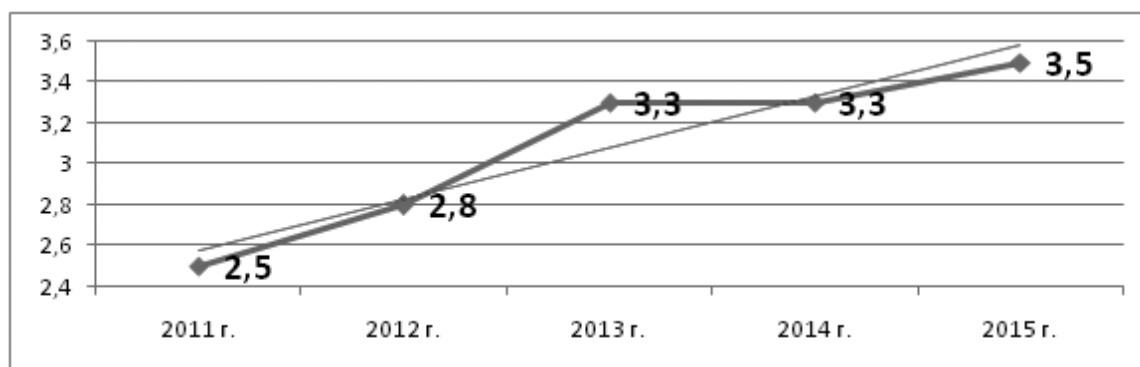


Рисунок 1 – Показатель заболеваемости РЩЖ в РК за 2011–2015 годы (‰)

Известно, что недостаток поступления йода, радиационное излучение или их сочетание увеличивают риск развития РЩЖ в несколько раз. Определенную роль в риске возникновения РЩЖ играют и особенности конкретного региона, имеющего свой фон окружающей среды с наличием канцерогенных факторов [8,9]. Анализ заболеваемости в различных регионах страны показал, что лидерами по данной нозологии являются Карагандинская и Северо-

Казахстанская области. При сравнении данных 2011 г. и 2015 г. очевидно, что соотношение республиканских и региональных показателей этих областей не изменились и остались на уровне 2,1-2,3/1. Следующими по уровню заболеваемости РЩЖ стабильно остаются города Алматы и Астана, Кызылординская, Восточно-Казахстанская и Актюбинская области (рисунок 2).

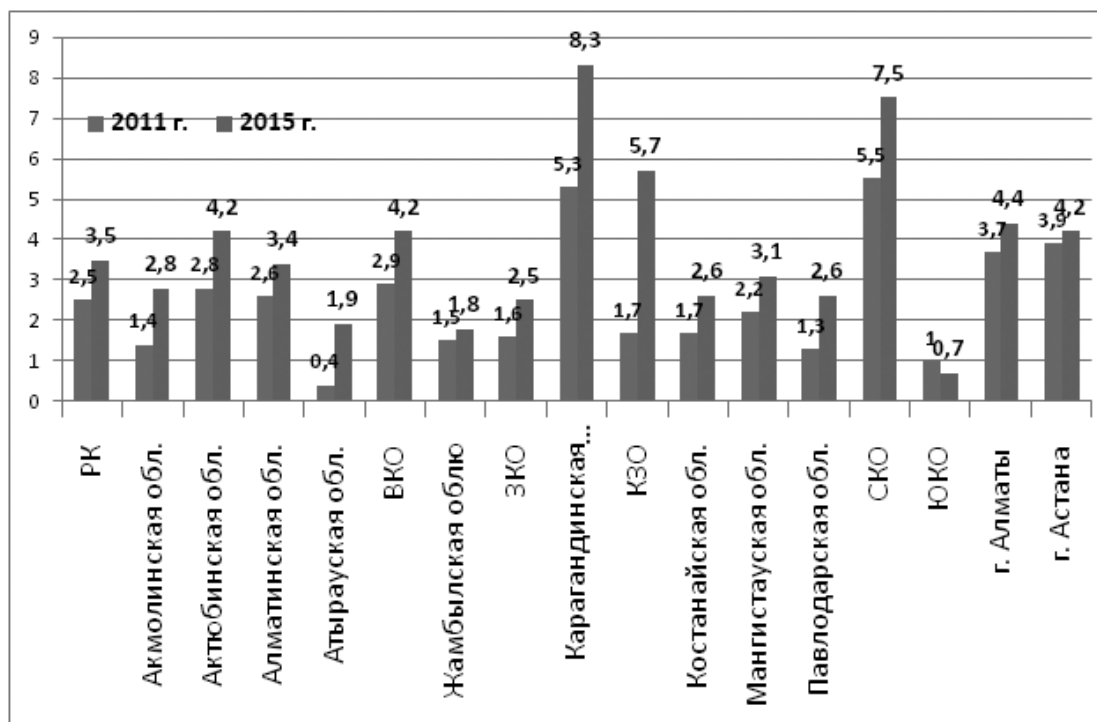


Рисунок 2 – Динамика заболеваемости РЩЖ в РК за 2011 – 2015 годы (%00)

Факторы, играющие определяющую роль в этиологии РЩЖ, разнообразны. Рост заболеваемости РЩЖ в северных и восточных регионах Казахстана, может быть объяснен сочетанием эндемии и возрастающего влияния антропогенных факторов: повышение уровня промышленного производства, урбанизация, загрязнение окружающей среды техногенными токсическими веществами. [10]. По данным А.К., с ссылкой на Charles Land, распространенность патологии щитовидной железы на северо-востоке Казахстана вблизи Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП) составила 18% и 39% среди мужчин и женщин соответственно [11,12]. В регионе выявлена прямая связь новообразований щитовидной железы от ионизирующего облучения [13], полиморфизма генов [14] и хромосомных aberrаций [15].

Еще одна особенность РЩЖ – ассоциация его с полом и возрастом. По данным Ries L.A.G., et al (2006), которые провели анализ статических данных за период с 1975 по 2003 г.г., около 65% новообразований выявляется до 55 лет, за исключением, возможно, анапластической карциномы [16,4]. Этот факт свидетельствует о том, что старение не является одним из ведущих факторов риска в отношении РЩЖ.

Согласно данным Мауеновой Д.К. и соавт. (2011 г.), при анализе 2 903 больных РЩЖ в РК, высокий удельный вес больных был выявлен в возрасте 50-59 лет (26,4%), сред-

ний возраст пациентов составил 51,2 года. Авторы сделали вывод об «омоложении» РЩЖ [17].

Известно, что важную роль в возникновении РЩЖ играет пол пациента. По разным эпидемиологическим данным установлено, что опухоли ЩЖ возникают у женщин в 3–10 чаще, чем у мужчин [18,19]. Почему этот фактор является одним из определяющих в риске развития злокачественных изменений в щитовидной железе объяснить в настоящее время сложно. Тем не менее, одной из причин считают наличие функциональных связей, которые имеются между щитовидной железой и репродуктивной системой [9].

Оценка распределения РЩЖ по полу в Республике Казахстан за 2011 – 2015 г.г. показала, что в структуре заболеваемости РЩЖ преобладают женщины. РЩЖ в структуре женской онкозаболеваемости стабильно занимает 13-14 места, а в структуре онкозаболеваемости у мужчин – 19. Средний показатель соотношения числа заболевших женщин к мужчинам составил за 5 лет составил 6,0/1, т.е. ежегодно в Казахстане среди пациентов с впервые выявленным РЩЖ в 6 раз больше женщин.

Несмотря на наружную локализацию щитовидной железы, проблема своевременной диагностики рака остается актуальной. Сложности в диагностике связаны часто с тем, что онкологический процесс зачастую «прикрыт» или развивается на фоне другой патологии щитовидной

железы [20,21]. Этот факт подчеркивает актуальность проблемы и необходимость тщательного изучения факторов, которые могут послужить причиной или сыграть роль промоторов в возникновении опухолей щитовидной железы.

Динамический анализ данных по ранней диагностике злокачественных опухолей щитовидной железы в Казахстане показал положительную тенденцию в снижении доли пациентов с III-IV стадиями заболевания за 2011 – 2014 г.г. (рисунок 3).

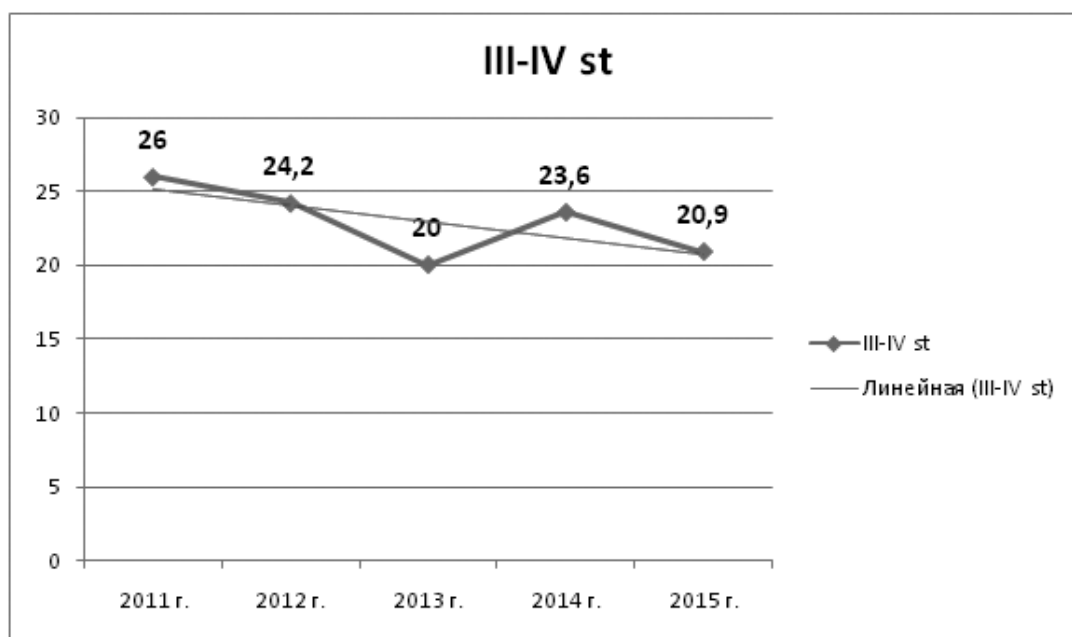


Рисунок 3 – Динамика удельного веса III-IV стадий РЩЖ за 2011-2015 г.г.

Тем не менее, каждый 5 пациент в стране диагностируется в запущенной стадии РЩЖ, что отражается на объеме и радикальности проводимого лечения.

Несмотря на положительную динамику в снижении

поздней диагностики злокачественных образований щитовидной железы, показатели 5-летней выживаемости больных этой патологией имеют тенденцию к снижению по данным 2011 – 2015 г.г. (рисунок 4).

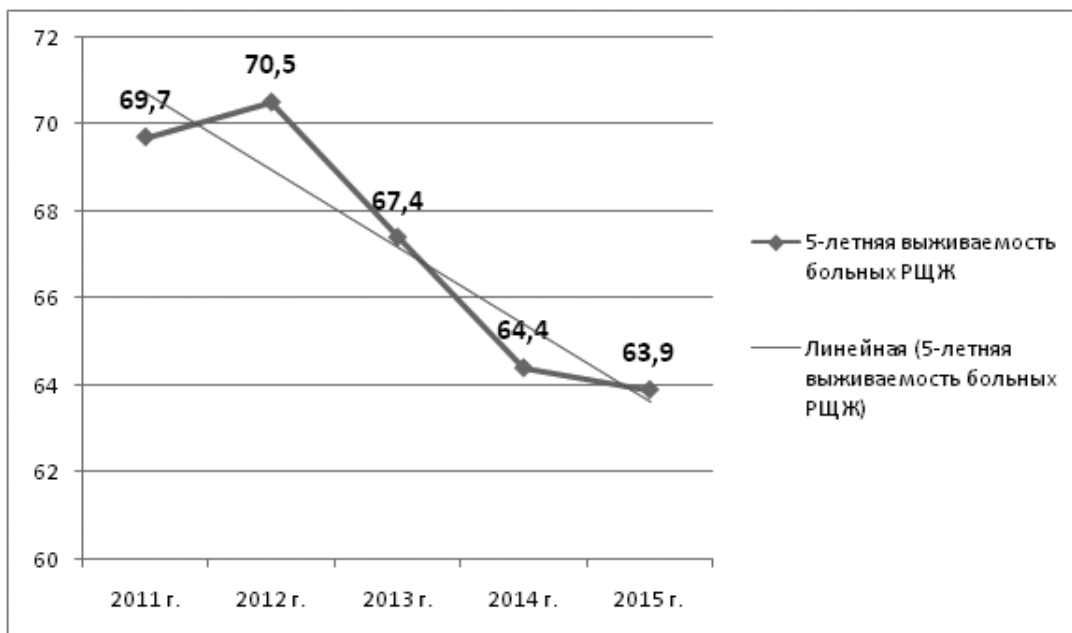


Рисунок 4 – Динамика 5-летней выживаемости больных РЩЖ за 2011-2015 гг.

Объяснить данный феномен достаточно сложно.

По смертности от РЩЖ, согласно данным GLOBOCAN (2012 г.) Казахстан относится к регионам с низкими показателями, сопоставимыми с Австралией, США, Канадой и странами Западной Европы, с частотой смертельных исходов менее 0,28‰ (стандартизованный показатель).

Республиканские данные за 2011-2015 гг свидетельствуют о стабильности данного показателя, он колеблется от 0,5 до 0,6‰, и занимает 23 строчку в структуре смертности от злокачественных новообразований.

Таким образом, в Республике Казахстан отмечен рост заболеваемости РЩЖ за последние 5 лет (2011-2015 гг.), что, видимо, может быть объяснено с экологической обстановкой, дефицитом йода, ростом урбанизации. В то же время, рост заболеваемости и снижение доли больных с

запущенными формами РЩЖ могут свидетельствовать об улучшении инструментальных методов диагностики.

С другой стороны, снижение показателей 5-летней выживаемости, остающаяся достаточно высокой доля пациентов с запущенными стадиями заболевания, преобладание женской популяции среди больных с диагностированными злокачественными опухолями щитовидной железы и достаточно молодой возраст пациентов, 50-59 лет, свидетельствует о сохраняющейся актуальности проблем профилактики, ранней диагностики РЩЖ, необходимости тесной координации с эндокринологами, терапевтами и врачами других специальностей, о повышении онкологической настороженности на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Список литературы

1. Валдина Е.А. Заболевания щитовидной железы // Руководство. – СПб: Питер., 2005.- 368с.
2. Романчишин А.Ф., Колосюк В.А., Богатурия Г.О. Рак щитовидной железы проблемы эпидемиологии, этиопатогенеза и лечения. – СПб.: WELCOME, 2003. – 256 с.
3. Schlumberger M.J. Papillary and follicular thyroid carcinoma // New Engl. J. Med. – 1998. – Vol. 338(5). – P.2977306.
4. Л.М. Берштейн. Рак щитовидной железы: эпидемиология, эндокринология, факторы и механизмы канцерогенеза // Практическая онкология.-2007.- Т. 8, № 1 – С. 1-8.
5. GLOBOCAN 2012. www.Globocan.iarc.fr
6. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Ж., Байпеисов Д.М. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2012 г. (статистические материалы).
7. Нургазиев К.Ш., Байпеисов Д.М., Сейсенбаева Г.Т., Ажмагамбетова А.Е., Жылкайдарова А.Ж. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2014 г. (статистические материалы).-Алматы, 2015.
8. Nagataki S., Nystrom E. Epidemiology and Primary Prevention of Thyroid Cancer // Thyroid.- 2002.- Vol. 12, №10.- P. 889–896.
9. А.Б. Шинтияпина, С.П. Шевченко, С.В. Сидоров, Л.Ф. Гуляева. Эпидемиологическая характеристика и оценка факторов риска рака щитовидной железы в г. Новосибирске // Сибирский онкологический журнал.- 2011.- №1 (43).- С. 44-50
10. Lukas J., Drabek J., Lukas D., Dusek L., Gatek J. The epidemiology of thyroid cancer in the Czech Republic in comparison with other countries // Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky. - Czechoslovakia: Olomouc, 2012. - P. 266-275
11. Алдынгуров Д.К. Медико-социальные аспекты совершенствования реабилитации больных с заболеваниями щитовидной железы.. диссерт. на соискание ученой степени доктора философии (PhD) 6D110200 – Общественное здравоохранение, 2013.
12. Land C.E., Zhumadilov Zh., Gusev B.I. et al. Ultrasound-detected thyroid nodule prevalence and radiation dose from fallout // Radiation research. - 2008. - Vol. 169, № 4. - P. 373–383.
13. Zhumadilov Zh., Hoshi M., Takeichi N. et al. Some approaches to treatment of patients with thyroid nodular diseases in the Semipalatinsk region of Kazakhstan // Hiroshima Journal Of Medical Sciences. - 2003. - Vol. 52, № 4. - P. 81–89.
14. Sigurdson A., Land C., Bhatti P. et al. Thyroid nodules, polymorphic variants in DNA repair and RET-related genes, and interaction with ionizing radiation exposure from nuclear tests in Kazakhstan // Radiation research. - 2009. - Vol. 171, № 1. - P. 77–88.
15. Takeichi N., Hoshi M., Iida Sh. et al. Nuclear abnormalities in aspirated thyroid cells and chromosome aberrations in lymphocytes of residents near the Semipalatinsk nuclear test site // Journal of radiation research.- 2006. - P. 171–177.
16. Ries L.A.G., Harkins D., Krapcho M. et al. (eds.) SEER Cancer Statistics Review, 1975-2003. National Cancer Institute, Bethesda, MD. <http://seer.cancer.gov/csr/1975--2003/>, posted to the SEER web site 2006.;
17. Мауенова Д.К., Игисинов Н.С. Особенности заболеваемости раком щитовидной железы в Казахстане // Молодой ученый. – 2011. –Т.2, №5 – С.188-191.
18. Берштейн Л.М. Онкоэндокринология: традиции, современность и перспективы.- СПб.: Наука, 2004.- 343 с.
19. Nagataki S., Nystrom E. Epidemiology and Primary Prevention of Thyroid Cancer // Thyroid.- 2002.- Vol. 12, №10.- P. 889–896.
20. Matos P.S., Ferreira A.P., Ward L.S. Prevalence of papillary microcarcinoma of the thyroid in autopsy and surgical series // Endocr. Pathol.- 2006. -Vol. 17, № 2.- P. 165–173.
21. Schlumberger M.J. Papillary and follicular thyroid carcinoma // New Engl. J. Med.- 1998. -Vol. 33, № 5.- P. 297–306.

Тұжырым**Д.Р. Кайдарова, М.Е.Кайбаров****Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты****SUMMARY****D. R. Kaidarova, M.E. Kaibarov****Kazakh Scientific-research Institute of Oncology and Radiology****Қазақстан Республикасындағы қалқанша без қатерлі ісігінің эпидемиологиялық аспектілері****Epidemiological aspects of thyroid cancer in the Republic of Kazakhstan**

Дүние жүзінде қалқанша бездің қатерлі ісігі дертінің айқын өсуі байқалады. Қалқанша бездің қатерлі ісігінің негізгі бөлігі эпителиалды ісік ретінде кездеседі, олар өздігімен жоғары және төменгі дифференциациялы ісіктерге, және де медуллярлы карциномаларға жіктеледі. Сондықтан Қазақстан Республикасында қалқанша бездің қатерлі ісігінің эпидемиологиялық аспектілерін зерттеу қажет ететіні мәлім.

Қазақстан Республикасында соңғы 5 жылдықта (2011-2015жж) қалқанша бездің қатерлі ісігі ауруының өсуі байқалады, бұл деңгейді экологиялық жағдаймен, йод тапшылығы және де урбанизацияның өсуімен түсіндіруге болады.

Түйінді сөздер: қалқанша бездің қатерлі ісігі, эпидемиология, Қазақстан Республикасы.

In the world there has been a steady increase in the incidence of thyroid cancer. The main share of malignant neoplasms of the thyroid gland provided Epithelial tumors, which are divided into the highly differentiated, poor differentiated and medullar carcinoma. In connection with this is the need to study the epidemiological aspects of thyroid cancer in the Republic of Kazakhstan.

In the Republic of Kazakhstan has been marked increase in morbidity of thyroid cancer for last 5 years (2011-2015), which probably can explain the environmental conditions, iodine, increasing urbanization.

Key words: cancer of the thyroid gland, epidemiology, the Republic of Kazakhstan